

M4 精神系コース 2026.4.14

医学的疾患による精神障害 およびコンサルテーション 精神医学

目次

医学的疾患による精神障害

- 症状性精神障害
- 中毒性精神障害
- 器質性精神障害

コンサルテーション・リエゾン精神医学とは？

医学的疾患による精神障害

正式な診断名

- ICD-10：器質性精神障害（症状性を含む）
- DSM-5-TR：他の医学的状态による精神症

定義：その精神症状が、背景にある身体疾患の直接作用により起こっていると合理的に説明ができるものすべて

医学的疾患による精神障害とは

- 脳以外の身体疾患による精神疾患（症状性精神障害）
 - S L E 精神病 肝性脳症等
- 化学物質の長期暴露や中毒（中毒性精神障害）
 - 一酸化炭素中毒 水銀中毒等
- 脳の器質病変による精神疾患（器質性精神障害）
 - 脳腫瘍 頭部外傷等
- 症状
 - 急性の精神症状の全てが出現しうる
 - 幻覚・妄想・躁状態・うつ状態・意識障害等

医学的疾患による精神障害 の診断のポイント

- 精神障害の既往歴と家族歴の聴取
- 常用薬物と現在の処方内容の把握
- 身体症状と諸検査データの理解
- 精神症状の発現時期と経過の把握
- 現症の正確な理解の為の病前情報入手
- 精神症状の評価と必要な検査の実施
(脳波等)

目次

医学的疾患による精神障害

- 症状性精神障害
- 中毒性精神障害
- 器質性精神障害

コンサルテーション・リエゾン精神医学とは？

症状性精神障害とは？

- 脳以外の身体疾患の際に発現する精神障害
- 症状性精神病の中には、身体疾患が脳に影響して、機能障害が生じて発現するものや、機能障害だけにとどまらず、器質的な変化が生じて発現するもの、その両者によって発現するものがある。（器質性精神障害とoverlapするものがある。ex.全身性エリテマトーデス：脳血管内にも病変が生じる）

症状性精神障害の例

疾患の種類	例
内分泌疾患	下垂体機能低下症・甲状腺機能低下症/亢進症・副甲状腺機能低下症/亢進症・addison病・Cushing症候群・月経関連障害
代謝性障害	尿毒性脳症・肝性脳症・低血糖性脳症・糖尿病性ケトアシドーシス・急性間欠性ポルフィリン症・Wernicke脳症・電解質代謝障害
膠原病	SLE精神病・Bechet病
医原性	せん妄・薬物による精神障害（ステロイド・インターフェロン・抗Parkinson病薬等）

内分泌疾患に伴う精神障害

① 甲状腺機能障害

- 甲状腺機能亢進症
 - Basedow病に伴うものが多い
 - 身体的には交感神経活動の亢進状態
 - 精神症状は気分の変化が主で、躁状態が多い（うつや幻覚妄想状態を呈することもある）
 - 甲状腺中毒クリーゼを起こすと高熱や頻脈、発汗増加に加えてせん妄などの意識障害を中心とする精神症状を呈することもある

甲状腺機能亢進症

- 診断のポイント
 - 特有の身体症状
 - 甲状腺腫、眼球突出、頻脈、基礎代謝亢進、振戦
 - 精神症状
 - 躁状態 統合失調症様状態 不安 焦燥
- 鑑別診断：躁病、統合失調症
- 発生頻度：人口1000人に対し0.4–0.8人
- 特徴：20～40代の女性に多い
- 治療法
 - 精神的治療：
 - 薬物療法：抗精神病薬 気分安定薬
 - 身体的治療：
 - 薬物療法：抗甲状腺薬 甲状腺亜全摘
 - 放射線ヨード治療

症例：症状のポイント

32歳 女性 飲食店店員

主訴：怒りっぽい 言動がまとまらない

現病歴：この3ヶ月食事をとっているにもかかわらず、**体重が減少し**、**頸部の腫脹**が目立ってきた。職場でも疲れやすく、**動悸**や**発汗**が気になるようになった。**眠れない**日が続き、**不安**が強くなり、家族や職場の同僚に対しても、いらいらすることが多くなった。徐々に怒りっぽくなり、最近は**会話が成り立たない**。

甲状腺機能低下症

- 原発性と二次性＜下垂体機能低下（TSH分泌低下による＞のものがある
- 精神症状はうつ状態が多い
（他無関心や意欲低下、記名力低下等）
- 鑑別はうつ病、統合失調症等

50歳女性。ぼーっとした様子になったことを心配した家族に連れてこられて来院した。もともと明るい性格で、家事やパートタイムの仕事を活発にしていたが、一ヶ月前に長男が大学受験に失敗した頃から「ゆううつだ。元気が出ない。」と訴え始めた。家族によると2週間前に自宅の近くの診療所を受診し抗うつ剤と睡眠薬を処方されたが改善せず、数日前からぼーっとした様子になったという。家事の手際が普段よりはるかに悪く、時間がかかっている。5年前に人間ドックで慢性甲状腺炎を指摘されていた。診察時、抑うつ気分や意欲の低下、及び注意機能の低下が見られた。頭部MRIでは異常を認めない。脳波検査では基礎波として広汎な8-9Hzのα波がみとめられた。

この患者に見られる精神障害として最も考えられるのはどれか？

A. 気分障害→×：ライフイベントを契機とした2週間以上継続する抑うつ傾向を認めるが、気分障害の診断には身体疾患の除外が必須

B. 適応障害→×：ストレスになったイベントに対する主観的な苦痛の訴えがない

C. 解離性障害→×：解離性障害の症状は意識障害や知覚障害

D. 症状性精神障害→○：慢性甲状腺炎の精神症状として、自発性、注意集中力の低下が見られ、感情不活発や動作緩慢などが見られる

E. Alzheimer型認知症→×：記銘力の障害がない

内分泌疾患に伴う精神障害

②副甲状腺機能障害

- 副甲状腺機能亢進症
 - 血清Ca[↑]により
 - 身体的には頭痛・易疲労性・徐脈
 - 精神的には意欲減退・無力感・抑うつ気分等
- 副甲状腺機能低下症
 - 血清Ca[↓]により
 - 身体的には異常感覚・テタニー・けいれん発作
 - 精神的には抑うつ・情動不安など

内分泌疾患に伴う精神障害

③副腎皮質機能障害

- 副腎皮質機能亢進症
 - C u s h i n g 症候群（血清コルチゾール↑）
 - 身体的には顔面・上肢帯への脂肪沈着（中心性肥満）、多毛、高血圧、月経異常
 - 精神的には抑うつが多い（時に躁状態も）
- 副腎皮質機能低下症
 - 原発性（副腎機能不全）Addison病
 - 他下垂体前葉機能低下による二次性のものも
 - 精神的には気分障害が多い

内分泌疾患に伴う精神障害

④下垂体機能障害

- 下垂体前葉機能亢進症
 - 成長ホルモンの分泌過剰 巨人症 先端巨大症
 - 精神活動の低下や無気力、知的能力障害
- 尿崩症
- 抗利尿ホルモン(ADH)は視床下部で産生、下垂体後葉に貯蔵
 - ADH↑：ADH不適合分泌症候群（SIADH）
 - Na↓
 - 意欲低下や感情不安定→意識障害やけいれん
 - Na<135で注意

月経関連障害

- 月経前症候群（Premenstrual syndrome : PMS）
 - 月経前期に変動が大きく、月経の開始と共に終了
 - 月経周期に起こるホルモンの変化が原因と言われている
 - 焦燥・不安・易刺激性・抑うつ・倦怠感・食欲亢進などが生じる
 - DSM-5における月経前不快気分障害にほぼ該当

ピルの副作用

MARTELL ET AL. CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE MEDICINE 2023

目的

- ピルに関する患者側の主観的な経験とその副作用に関して述べること

方法

- 生涯の中でピルを使ったことのあるコンビニエントサンプルを対象とした横断研究

結果

- 188人が参加
- 44%が一度は副作用としての気分の変動を経験した
- 精神科既往のある人はない人と比べてより気分の変動を感じやすかった (61%)
- 精神科既往のある人では39%が精神症状の増悪を感じ、11%が精神症状の改善を感じた

妊娠・産褥期に伴う精神障害

- 妊娠中

- 不安・抑うつ

- 産褥期（分娩後 6 週間以内）

- 産褥期精神病

- 産婦の 1 ～ 2 % に発症
 - 分娩後 1 週以内に発症することが多い
 - 比較的短期期間で改善する
 - 分娩による精神的・社会的ストレス＋内分泌などの生物学的要因
 - 気分障害、統合失調症様症状など
 - 内因性精神病の誘発や再発の原因にも

マタニティブルーと産後うつ病の鑑別

特徴	マタニティブルー (産後のうつ状態)	産後うつ病
頻度	産後女性の50%	産後女性の10%
発症時	産後3-5日	産後3-6ヶ月以内
持続	数日から数週間	治療されなければ数ヶ月から数年
関連するストレス因	なし	あり：特に精神的な支えの欠如
気分障害の既往	関連なし	強い関連性あり
快楽消失	なし	しばしば
自殺念慮	なし	時々
子供を傷つける考え	稀	しばしば
罪責感	なし、または軽度	しばしば存在し、強い
睡眠障害	時々	ほとんど常に

マタニティ・ブルーズについて
正しいのはどれか。

- a. 症状は2か月以上続く
- b. 産褥3～10 日頃に発症する
- c. 大半は産後うつ病に移行する
- d. 症状として幻聴が特徴的である
- e. 我が国の発症率は欧米よりも高い。

産後うつ病の重症度の目安

軽症のうつ病	診断基準を満たすために必要な数以上の症状が全どない 苦痛はあるがなんとか対応できる ある程度家事や育児を行うことができるが楽しめない
中等症のうつ病	軽症と重症の間
重症のうつ病	症状の数が診断を下すために必要な項目数より十分に多い 症状の強さは非常に苦痛で手に負えない程度 家事や育児を行うことは著しく困難 「赤ちゃんに対して何も感じない」といった阻隔感 「赤ちゃんが病気になっている」といった妄想 自身や赤ちゃんを傷付けたいという考え

更年期に伴う精神障害

更年期障害

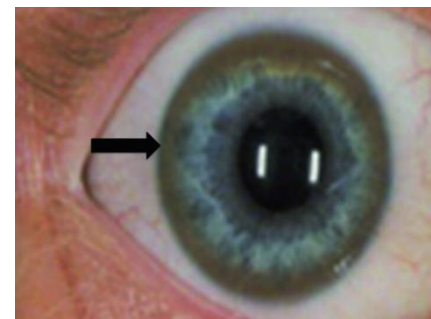
- 閉経に伴う急激なホルモン変化、加齢に伴う身体的変化、女性としての機能喪失感等が影響
- 女性に多いが最近では男性も？
- 治療はホルモン補充療法、漢方など

代謝障害による精神障害

①肝臓疾患

● Wilson病

- 常染色体劣性遺伝の先天性銅代謝異常疾患
- 頻度：人口10万人当たり、1.7-2.4人
- 好発年齢：2-25歳（12歳前後）
- 尿中銅代謝↑
 - Kayser-Fleischer<カイザーフライシャー>輪
 - 精神症状：感情不安定、抑制欠如
- 身体症状：腹部症状、肝障害、筋強剛、羽ばたき振戦、けいれん発作など
- 治療：銅の沈着を阻止し、排泄を促す薬剤（D-ペニシラミン、ジメルカプロールなど）



（角膜への銅沈着）

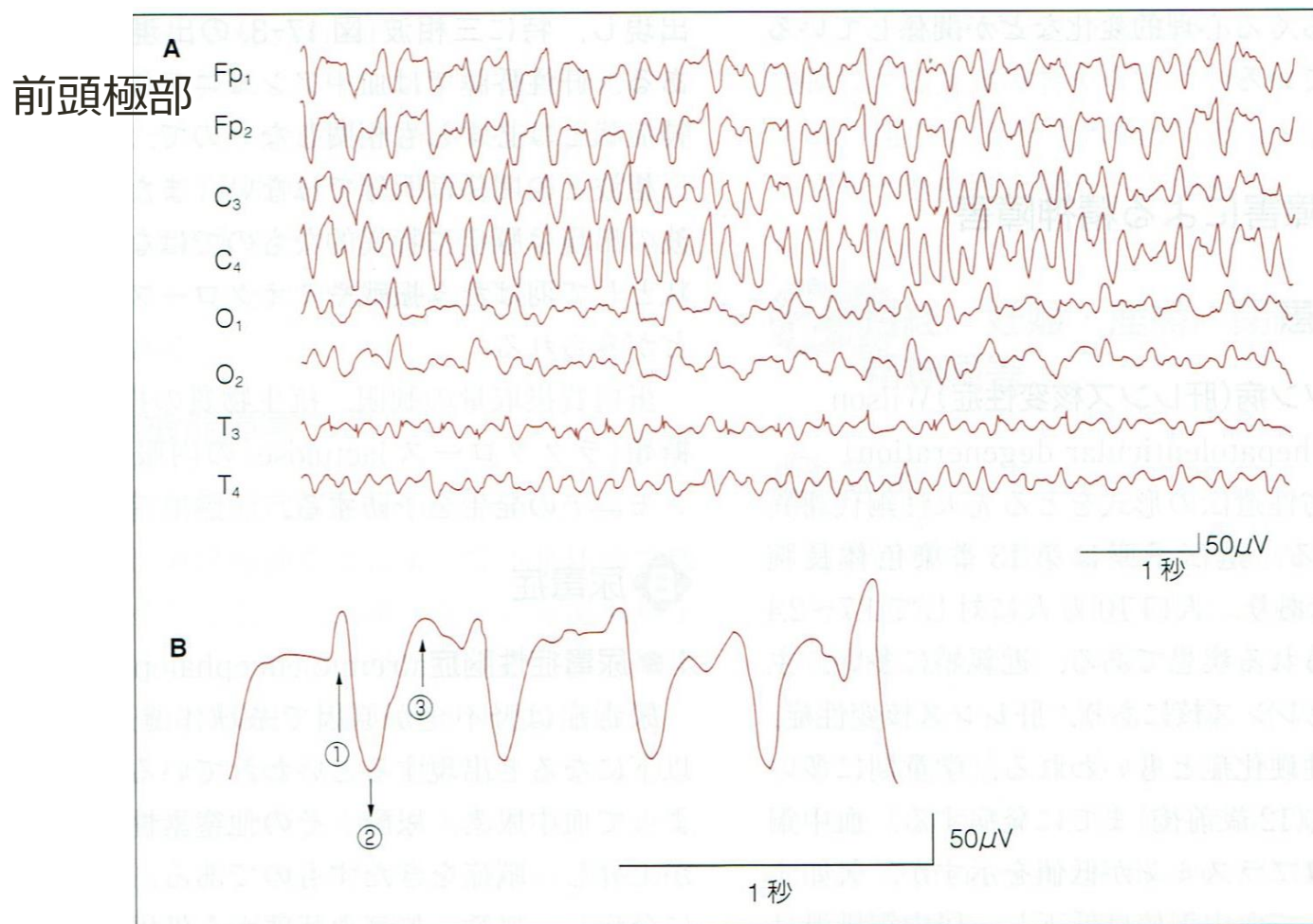
代謝障害による精神障害

①肝臓疾患

- 肝性脳症

- アンモニアなどの毒素が肝臓で代謝されず脳が障害されて起こる脳症
- 精神症状：意識障害
 - 軽度の意識混濁～錯乱、もうろう状態、昏睡
- 脳波上除波が出現：3相波
- 血中アンモニア↑
- 神経症状：羽ばたき振戦、ミオクローヌスなど

三相波



鋭波の下降部分が緩やかに陽性方向に揺れ(②)、その前後に小さな陰性の揺れがある三相波

代謝障害による精神障害

② ビタミン欠乏症・電解質代謝異常

- ビタミン欠乏症

- ビタミンB 1 不足：Wernicke脳症

- アルコール依存が基盤

- 急性の眼筋麻痺、失調性歩行、意識障害が3兆候
(意識障害で気づかれることが多い)

- 電解質代謝異常

- 脱水、大量輸液等血中のNa, Ca, Mg等の代謝異常

- 精神症状：意識障害等

膠原病による精神障害

①全身性エリテマトーデス(SLE)による精神障害

- 免疫複合体の組織沈着により起こる全身性炎症性病変を特徴とする自己免疫疾患
- 人口10万人あたり10～100人で20～30歳代の女性に好発
- 全身症状（倦怠感・易疲労感・発熱）のほか、皮膚粘膜・筋関節・腎・神経・心血管・肺・消化器・造血器に多彩な症状が生じる
- 10年生存率は2000年代には90%まで上昇
- しかし神経精神障害と腎障害は生存率に悪影響

全身性エリテマトーデスによる精神障害

- 米国リウマチ学会の分類基準ではSLEにより精神神経症状を伴うものをneuropsychiatric SLEと定義

SLEによる精神神経症状の出現頻度

Unterman A 2011

NPSLE症状		頻度 (%)	95%CI
中枢神経病変	神経症状		
	頭痛	28.3	18.2-44.1
	けいれん	9.9	4.8-20.5
	脳血管障害	8.0	4.5-14.3
	運動障害（舞踏病）	0.9	0.3-2.7
	脊髄症	0.7	0.2-2.3
	脱髄性症候群	NA	NA
	無菌性髄膜炎	NA	NA
	びまん性精神的・精神神経症候（精神症状）		
	気分障害	20.7	11.5-37.4
	認知機能障害	19.7	10.7-36.0
	不安障害	6.4	3.0-13.6
	精神病性障害	4.6	2.4-8.8
	急性錯乱状態	3.4	1.1-10.3

SLEによる精神神経症状の出現頻度

Unterman A 2011

NPSLE症状		頻度 (%)	95%CI
末梢神経病変	多発神経炎	2.3	0.7-7.8
	脳神経障害	2.2	1.2-4.1
	単神経炎 単発/多発	0.9	0.3-2.9
	自律神経障害	NA	NA
	急性炎症性脱髄性多発 神経根神経炎 (ギランバレー症候 群)	NA	NA
	重症筋無力症	NA	NA
	神経叢炎	NA	NA

SLEに伴う精神症状

- 抑うつ症状は17-75%に生じる
 - 易疲労感が最も多くSLEの症状と関連している
 - 易刺激性、心気症状、入眠困難：7割以上
 - 悲しみ：29-70%
 - 希死念慮：抑うつ状態の患者のうち10-34%
- 精神病症状
 - 成人では32%で初発時に出現
 - 小児では17%が診断される6ヶ月前以上に出現
 - 幻視・幻聴が多く、幻触や妄想も

SLEによる精神症状

- NPSLEの自殺のリスクは高くSLEの死因の6%を自殺が占める
 - 小児：20%に希死念慮、6%が自殺企図
 - 成人：8～34%に希死念慮、2%が自殺企図
- NPSLEに特異的な脳の病理所見は明らかではない
 - 微細な梗塞や出血などと結びついた血管障害が多い
 - 精神症状を示すものには明らかな病理的所見を欠くものも
- 精神症状は自己抗体、免疫複合体、サイトカイン、ケモカインなどに関連した免疫機序が複雑に関与すると推測されている

SLEに伴う精神症状

- 約 8 割がNPSLEによるもの
 - その他に抗リン脂質抗体症候群,壊死性血管炎
 - 合併症によるものとして感染性髄膜炎、ステロイド精神病、脳血管障害、尿毒症が挙げられる

SLEによる精神症状（経過）

- NPSLEによる精神症状はSLEと診断される前にも生じるが、50~60%は診断後1年未満で生じ、活動性が高い時期に生じやすい
- 急性期をすぎても残存し、回復には数カ月を要する

SLEに伴う精神症状 (ステロイド精神病との鑑別)

- ステロイド精神病との鑑別はしばしば問題に
 - ステロイドを開始した後に精神症状が出現した際、必ずしもステロイド精神病とは診断できない
 - NPSLEはステロイド開始または増量後に顕在化することがあり、まずは潜在的なNPSLEがステロイドによって顕在化したことを前提とした治療を

SLEに伴う精神症状 (治療)

- 原疾患の治療を優先。対症療法的に向精神薬を投与（エビデンスは十分ではない）
 - 抗うつ剤：パロキセチンやセルトラリン
 - 抗精神病薬：リスペリドン、オランザピン、クエチアピン、アリピプラゾール
 - 気分安定薬：リチウム、VPA
 - 心理的介入が不安・抑うつ・ストレス等に有用との報告も Zhang 2012

膠原病による精神障害

②神経ベーチェット病

- 好発年齢・性別：20代の男性
- ベーチェット病発症から神経ベーチェット病発症までは2-20年
- 予後不良
- 身体症状：口腔内アフタ性潰瘍、陰部潰瘍、前房蓄膿性虹彩炎（ぶどう膜炎）が3主徴
- 神経症状：全身けいれん発作、四肢の痙性麻痺、錐体外路症状、知覚麻痺等
- 精神症状：不安、焦燥、人格変化、認知症

医原性精神病

①せん妄

せん妄とは？

【DSM-5-TRによる診断基準】

A: 注意の障害

- 注意を方向づけ、集中、維持、転換する能力の低下

B: 急性発症、日内変動

- 数時間から数日のうちに出現
- 1日の経過中で重症度が変動（夜間に増悪することが多い）

C: 認知の障害

- 記憶欠損、失見当識、知覚障害（幻覚・妄想）

D: 他の既存の、または進行中の神経認知障害では説明できない

E: 原因となる医学的疾患、薬物により引き起こされたという証拠がある

せん妄の発生要因

準備因子（なりやすい人）

- せん妄の本態である、脳機能低下をきたしやすい個人の特性

促進因子（なりやすい環境）

- これによって直接せん妄が発症することはないが、ひとたび発症したせん妄を促進、重篤化、遷延する要因

直接因子（せん妄の生物学的直接原因）

- 文字通り、せん妄そのものの原因

せん妄の準備因子

せん妄の本態である脳機能低下を来たし やすい個人特性

- 高齢
- 脳血管障害の既往など、脳の器質的病変の存在
- 認知症ないしその前駆症状（認知機能障害）
- アルコール多飲歴
- せん妄の既往歴

せん妄の促進因子

* これによって発症することはない（直接の原因ではない）
が、ひとたび発症したせん妄を促進・重篤化・遷延化する
要因

- 環境の変化
- 感覚遮断（聴力や視力の障害など）
- 睡眠・覚醒リズムの障害
- 治療上の身体拘束、強制臥床
- 不快な身体症状（疼痛、呼吸困難、便秘、排尿障害・尿閉）
- 心理的ストレス

せん妄の直接因子

中枢神経系への直接浸潤

脳転移、髄膜炎、脳血管障害

臓器不全による代謝性脳症

肝・腎機能障害、呼吸不全

電解質異常

高Ca血症、低Na血症、脱水

薬剤性

オピオイド、ステロイド
睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬
H2-blocker、抗コリン薬

感染症

肺炎など

血液学的異常

貧血、DICなど

栄養障害

全身性栄養障害（悪液質）

腫瘍随伴症候群

ホルモン産生腫瘍等

身体的侵襲

外傷、手術

せん妄について正しいのは
どれか。3つ選べ。

a 脱水は発症要因となる

b 治療によらず改善は見込めない

c 数時間から数日で急速に発症する

d 身体疾患を背景に持つことが必須である

e 日内変動がありしばしば夜間に増悪する

せん妄の治療

- 環境調整
 - 一日の生活リズムの確立
 - 照明の調整（昼間明るく、夜適度に暗く）
 - 時計やカレンダーを置く、家族の面会
- 身体治療：せん妄の原因の除去
- 対症療法
 - 薬物療法：抗精神病薬（ハロペリドールなど）を使う
 - Don't!! 抗不安薬（睡眠薬・安定剤）

入院中の高齢者が夜間のせん妄を発症したとき、せん妄を増悪させるのはどれか。

- a. 家族との面会を勧める
- b. 日中の自然光を採り入れる
- c. 夜間は病室を真っ暗にする
- d. 病室にカレンダーを掲示する
- e. 時計を大きな文字盤のものにする

83歳の女性。右大腿骨頸部骨折のため手術を受けた。手術当日の夜は意識清明であったが、手術翌日の夜間に、死別した夫宅の食事を作るために帰宅したいなど、つじつまの合わない言動が出現した。これまで認知症を指摘されたことはない。

この病態について正しいのはどれか。

- a. 生命予後は悪化しない
- b. 抗精神病薬は禁忌である
- c. 認知症の初発症状である
- d. 意識の混濁が短時間で変動する
- e. ベンゾジアゼピン系薬剤が適応である

向精神薬とは

- 向精神薬（精神に働く薬全部）
 - 抗精神病薬（精神病に抗う薬）
 - Major tranquilizer
 - 抗不安薬（いわゆる安定剤）
 - Minor tranquilizer
 - 睡眠薬
 - 導入剤 ≡ 超短時間型
 - 抗うつ薬

せん妄と区別すべき病態 (認知症)

	せん妄	認知症
発症	急激	緩徐
初発症状	錯覚、幻覚、妄想、興奮	記憶力低下
日内変動	夕方や夕方に悪化	変化に乏しい
持続	数日～数週間	永続的
身体疾患	合併している事が多い	時に有り
薬剤の関与	しばしばあり	なし
環境の関与	関与する事が多い	なし

せん妄の分類

• 過活動型せん妄

- 運動量が増える・
- 活動のコントロールが悪くなる
- 落ち着きがない
- 徘徊する

• 低活動型せん妄

- 活動量が減る・行動が遅くなる
- 周囲に対する認識が下がる
- 会話量が減る・会話の速さが遅くなる
- 無関心・覚醒度が下がる・引きこもり
- うつと誤診されやすい

• 混合型せん妄

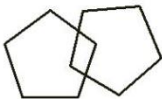
- 過活動型と低活動型の症状が混在

せん妄と区別すべき病態 2

(うつ状態)

	低活動型せん妄	うつ状態
発症様式	急性、亜急性	緩徐
覚醒度	覚醒度低下、傾眠	正常
認知機能	短期記名力障害 集中力低下、失見当識	主観的障害 ごく軽度
知覚障害	錯覚・幻覚	ごくまれ
感情	不安定、抑制欠如に基づく希死念慮（脈絡のない希死念慮）	絶望感、無価値観に基づく希死念慮（背景がわかる希死念慮）
神経学的所見	原始反射（把握反射等） 羽ばたき振戦	正常

MMSE

1. (5点)	今年は何年ですか？ 今の季節は何ですか？ 今日は何曜日ですか？ 今日は何月何日ですか？
2. (5点)	ここは何県ですか？ ここは何市ですか？ ここは何病院ですか？ ここは何階ですか？ ここは何地方ですか？（例：関東地方）
3. (3点)	物品名3個（相互に無関係。例：桜、犬、飛行機） 検者は物の名前を1秒間に1個言う。その後、被験者に繰り返させる 正答1個につき1点を与える。3個すべて言うまで繰り返す（6回まで）
4. (5点)	100から順に7を引く（5回で止める）
5. (3点)	3. で提示した物品名を再度復唱させる
6. (2点)	（時計を見せながら）これは何ですか？ （鉛筆を見せながら）これは何ですか？
7. (1点)	次の文章を繰り返す「みんなで、力を合わせて綱を引きます」
8. (3点)	3段階の命令「右手でこの紙を取り、それを半分に折って私にください」
9. (1点)	次の文章を読んで、その指示に従ってください「眼を閉じなさい」
10. (1点)	何か文章を書いてください
11. (1点)	次の図形を 写してください 

医原性精神障害 薬剤による精神障害②

ステロイド製剤

- コルチゾール、ACTHなどのステロイド剤を用いると（特にパルス療法など大量に使用後）急性精神病状態を呈することがある
- 症状性の精神障害かステロイド製剤による精神障害か鑑別が困難なことも少なくない
- 精神症状：躁状態、意識障害、幻覚妄想状態
- 精神症状への対応：ステロイド減量・中止
- 原疾患の治療のために減量できない際には対症的な向精神薬の投与も

ステロイドに伴う気分、行動、認知の変化

DUBOVSKY A N ET AL. PSYCHOSOMATICS 2012

- 最初は躁や軽躁が出現し、長期投与を続けると抑うつが出現

Bolanos S et al. 2004

- 抑うつ（35%）、躁（31%）、精神病（14%）、せん妄（13%）、混合状態（6%）という報告も

Lewis DA et al. 1983

- 多くの患者（4-7割）が精神病症状と気分症状を併せ持つという報告もあるがとそこまでは多くはない（1-2割）という報告もある

Lewis DA et al. 1983, Wada K et al. 2001, Goodwin FK et al. 1990

- 認知障害は短期のステロイド使用でも長期のステロイド使用でも生じる

ステロイドによる神経精神症状の発症には 容量反応性や確立された経時的変化があるのか？

DUBOVSKY A N ET AL. PSYCHOSOMATICS 2012

- プレドニゾロン量2.5mg/日でも神経精神症状の報告有り
- ただ、容量依存性は有り
 - 40mg/日以下では1.3%、41-80mg/日では4.6%、80mg以上/日では18.4%
Boston Collaborative Drug Surveillance Program
- プレドニゾロン40mg/日以上の人では77%で精神症状を生じた
Lewis DA et al. 1983
- プレドニゾロン換算60mg/日以上の人では全員にコルチコステロイド誘発性認知症が生じたという報告も
- 治療早期で発症することが多い
 - 86%が治療開始1週以内に発症
Hall PCW et al. 1979
 - 治療後平均11.5日後に発症、89%が6週以内に(62%が2週間以内に、39%が1週間以内に)発症との報告も
Lewis DA et al. 1983

医原性精神障害

薬剤による精神障害③

その他のホルモン製剤

- 甲状腺ホルモン製剤
 - 甲状腺ホルモン低下や遅延性うつ状態の治療に用いられる
 - 副作用：甲状腺機能亢進症の際に出現する精神症状と類似
- 経口避妊薬（ピル）
 - うつ状態、不安、焦燥などが出現することがある

医原性精神障害 薬剤による精神障害

④ PARKINSON病に関連した薬剤

- ドパミン作動薬
 - レボドパ：10–50%で幻覚症やせん妄、妄想などの精神症状を生じることがある。
 - 減量は困難で対処療法として抑肝散などの漢方も
 - 抗精神病薬の使用で抗コリン作用や抗ドパミン作用のためにせん妄やパーキンソン病の症状が悪くなることもあるので注意
- 抗コリン薬
 - 常用量でも不安、焦燥、幻覚妄想、せん妄が生じること
 - 減量や中止で対応

58歳男性。言動を心配した妻に付き添われて来院。50歳時に手指振戦が出現し、Parkinson病と診断されて、L-dopaによる治療が開始された。56歳時には、体の硬さが気になってL-dopaの増量を医師に懇願し、どんどん増量された。1年前頃から「自分が心で考えていることをテレビに出ている人が察知している」と思い始め、被害的な内容の幻聴が聞こえ出した。会社は休みがちとなって自ら退職したが、気分は高揚してパソコンに齧り付き、昼夜逆転の生活となった。インターネットに没頭して高額のものを購入する、性的欲求が亢進して妻に迫るようになり、拒まれると怒り出す。

対応として適切なのはどれか？

A. 抗不安薬を投与する→×抗精神病作用はない

B. 抗てんかん薬を投与する→×一部抗てんかん薬は気分安定薬としても作用するので全くの誤りではないが、第一選択ではない

C. 抗コリン薬を大量投与する→×精神症状はむしろ悪化する

D. 非定型抗精神病薬を投与する
→△：非定型抗精神病薬はドパミン遮断作用が弱いのでParkinson症状をあまり悪化させることなく抗精神病作用を発揮する。しかし、Parkinson病の患者へは慎重投与。

E. L-dopaの投与を直ちに中止する→L-dopaの突然の中止によって悪性症候群が生じる可能性があり、漸減しなくてはならない。

抗精神病薬

- 定型（第一世代）抗精神病薬と非定型（第二世代）抗精神病薬に大別
- 定型（第一世代）抗精神病薬は、錐体外路症状をしばしば伴う
- 非定型（第二世代）抗精神病薬は錐体外路症状が少ないという特徴がある
- 第一世代抗精神病薬は、ドパミンD₂受容体遮断作用の強弱により、ハロペリドールなどの高力値とクロルプロマジンやレボメプロマジンなどの低力値の薬物に便宜上分けることができる。高力値は抗幻覚・妄想効果が強く、低力値は鎮静効果が強いという特徴がある

医原性精神障害 薬剤による精神障害

④ その他

- 抗がん剤：フルオロウラシル、メトトレキサート
- 降圧剤：レセルピン（抑うつ）

正しいのはどれか。
3つ選べ。

A. レセルピンは躁状態を起こす
→×：むしろ、うつに注意

B. 抗ヒスタミン薬は焦燥感を起こす
→×：鎮静作用があり眠気を引き起こす

C. 抗Parkinson病薬はせん妄を起こす
→○：しばしば幻覚やせん妄を引き起こす

D. インターフェロンはうつ状態を起こす
→○

E. 副腎皮質ステロイドは気分変調を起こす
→○：躁状態、うつ状態、気分変調を引き起こす

目次

医学的疾患による精神障害

- 症状性精神障害
- 中毒性精神障害
- 器質性精神障害

コンサルテーション・リエゾン精神医学とは？

化学物質中毒などによる 精神障害①一酸化炭素中毒

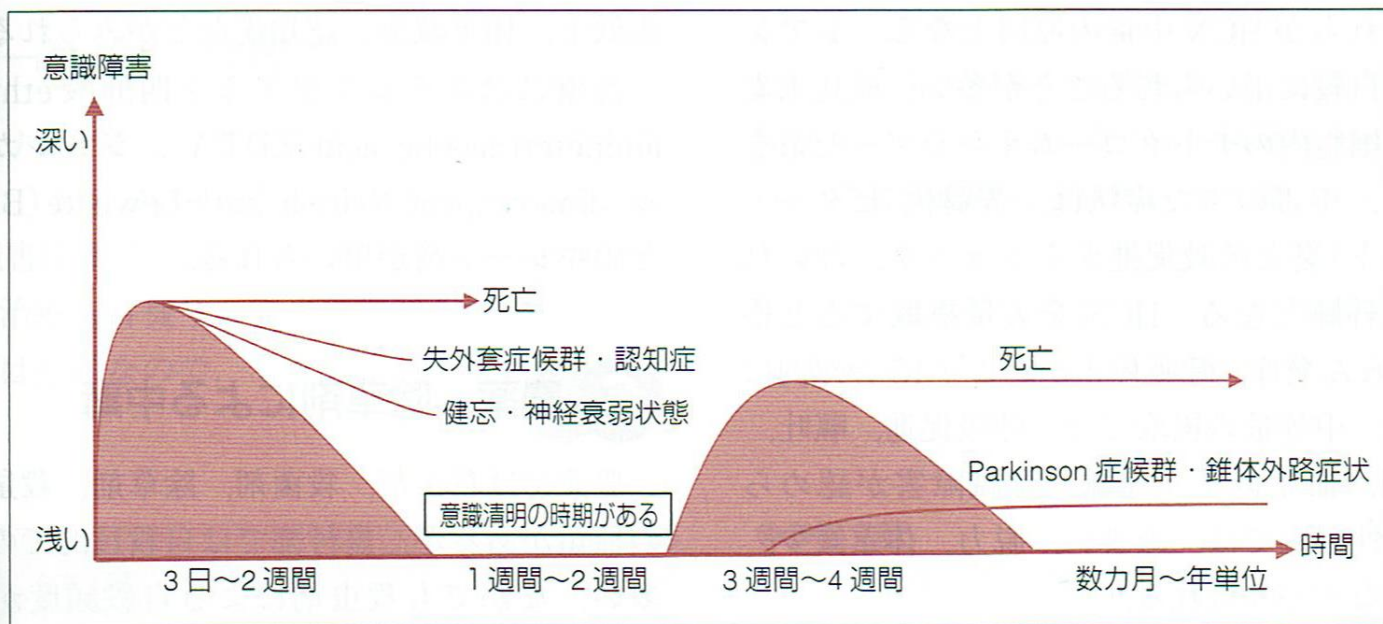


図 17-5 一酸化炭素(CO)中毒の経過

CO中毒はその曝露時間、濃度によって程度が異なるが、間欠型CO中毒があることが特徴である。

治療: 新鮮な大気中に移し、5%CO₂を含む酸素吸入＋新鮮血の輸血＋高圧酸素療法等
間欠型CO中毒には高圧酸素療法が良いという報告もある

化学物質中毒などによる 精神障害②その他

- 水銀中毒：大脳皮質に沈着し、巣症状
- 鉛中毒：せん妄、けいれん発作、健忘症候群
- 有機リン中毒：
 - 抗コリンエステラーゼ阻害作用によりアセチルコリンが過剰蓄積
 - 確定診断：血清コリンエステラーゼ値の低下
 - 薬物療法：アトロピン（抗コリン作動薬）

目次

医学的疾患による精神障害

- 症状性精神障害
- 中毒性精神障害
- 器質性精神障害

コンサルテーション・リエゾン精神医学とは？

器質性の精神障害

- 脳の局在性損傷に対応して出現する精神神経症状
 - 局在性神経症候や症状、画像検査、脳波、血液検査、髄液検査 遺伝子検査 病理所見などから脳器質病変の存在を確認
- 急性期：せん妄などの意識障害が中心
- 慢性期：人格変化や認知症に
- 薬物療法
 - 状態像に応じた薬物療法の選択（抗精神病薬 抗うつ剤 抗不安薬）
 - 神経症状に対する対症的薬物療法（抗パ剤 抗てんかん薬 ステロイド等）

器質性精神障害の例

疾患の種類	例・経過など
中枢神経変性疾患	Parkinson病 進行性核上性麻痺 Huntington病 脊髄小脳変性症 認知症を伴う運動ニューロン疾患
脱髄疾患	多発性硬化症 進行性多巣性白質脳症 散在性壊死性白質脳症 中心性橋白質融解症
脳腫瘍	意識障害、人格変化、知能障害 失語、失行、失認などの巣症状 幻覚症
頭部外傷	意識障害→幻覚症・健忘症・過敏性情動衰弱→頭部 外傷後後遺症（知能障害・人格変化・精神病症状な ど）が残ることも
脳炎	感染性脳炎 自己免疫性脳炎

パーキンソン病

- 発症年齢：50～60代が最も多い
- 人口10万人当たり100-120人程度発症
- 病態の中核：黒質緻密層の変性によるドパミン産出の低下
- 臨床症状
 - 神経症状**：振戦（上肢が主）、筋固縮（筋強剛）、無動（寡動や動作緩慢）、姿勢神経反射
 - 精神症状**：認知症（Dementia）、抑うつ（depression）＜神経症状発症前か発症後早期＞、せん妄（Delirium）の3Dや幻覚症＜人物・小動物＞
 - 抗パーキンソン病薬の投与が原因になることも

パーキンソン病により生じる 神経精神症状の頻度や発現時期

Connolly BS 2011

症状		出現時期	頻度 (%)
主要な 運動症状	静止時振戦	診断時または診断後	70 (診断時)
	動作緩慢	診断時	100
	筋強剛	診断時または診断後	90
初期 非運動障害	嗅覚障害	診断に先行しうる	25-97
	疲労感	診断に先行しうる	60
	うつ病	診断に先行しうる	25
	レム睡眠行動異常症	15年以上診断に先行しうる	30
	便秘	診断に先行しうる	30

パーキンソン病により生じる 神経精神症状の頻度や発現時期

Connolly BS

2011

症状		出現時期	頻度 (%)
末期症状	治療抵抗性体軸症状	症状出現後5－10年	
	すくみ足・姿勢不安定・転倒		90(15年後)
	嚥下障害		50(15年後)
	精神症状	症状出現後5－10年	
	不安		55
	自律神経症状	症状出現後5－10年	
	立ちくらみ		15
	流涎		30
	尿意切迫		35
	夜間頻尿		35
	性機能障害		20
	認知機能障害	症状出現時経過と共に増加	
	軽度認知機能障害		35(診断時) 50(5年後)
	認知症		80(20年後)

パーキンソン病に伴う精神症状 (抑うつ)

- PDが難治性疾患であるための反応性抑うつ症状であると考えられていたが、他の慢性神経疾患よりも合併率が高いことや、PDの発症前からうつ病の頻度が高くなることからPDの病態によると考えられる
- アパシー（うつ病と類似し、意欲の低下や興味の喪失が見られるが、感情が平板化しており、うつ病に見られる抑うつ気分や悲哀感、自責感はめだたず自殺は少ない）やアンヘドニア（性行為、食事、喫煙、飲酒などの喜びが得られるような刺激からの快楽の消失を基本とし、意欲・自発性の低下、社会性の喪失が見られる）が主

パーキンソン病に伴う精神症状（抑うつ）

- 中脳辺縁系や皮質辺縁系へのドパミン作動精神系の変性がアパシーやアンヘドニアを引き起こしているという説・青斑核のノルエピネフリン作動神経や背側縫線核のセロトニン作動性神経の減少が抑うつ症状に関与するという説がある
- 治療にはSSRIやSNRIがしばしば使用される
- TCAも有効性が認められているが、抗コリン作用により錐体外路症状や流涎を改善させる一方で、副作用としてふらつきや起立性低血圧、便秘を来たしうるため使いにくい

パーキンソン病に伴う精神症状 (認知機能障害)

- 経過期間と共に認知症の合併率が高まる
- 認知症を伴うPDでは思考の緩慢（精神緩慢）が目立ち、言語流暢性の障害が見られる
- 認知症を伴うPDでは、大脳アセチルコリンの濃度の低下が認められるため、治療にはリバスチグミンやドネペジル、ガランタミンを用いる

パーキンソン病に伴う精神症状 (精神病症状)

- 幻想的な景色や動物、人、虫などの幻視が多く、幻聴は少ない
- 軽症の場合には病識を有するが、重症になると訂正不能で日常生活に支障を生じる
- PDの進行と抗パ薬による中脳辺縁系ドーパミン系の活動亢進の双方が主な原因
- 日常生活に支障をきたす精神病症状を伴う際には原因となる抗パ薬の減量中止を検討
- それでも改善が得られない場合にはSDA又はチアプリド
 - クエチアピン（海外ではクロザピン）

パーキンソン病に伴う精神症状 (睡眠障害)

- 入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、過眠、睡眠発作、レム睡眠行動異常など
- 抗パ薬は、どの薬剤でも眠気を来たしうる
 - 非麦角系ドパミンアゴニスト（プラミペキソール・ロピニロール・タリペキソール）は眠気を来たしやすい
 - 過眠が見られたら麦角系ドパミンアゴニストに切り替える
 - 麦角系ドパミンアゴニストで眠気を生じたら減量
- レム睡眠行動異常症の場合にはクロナゼパム

パーキンソン病の治療

- 薬物療法：

- レボドパ製剤 レボドパ製剤の分解を防ぐ薬剤 ドパミン受容体刺激薬（ブロモクリプチン）ドパニン放出促進薬（アマンタジン）ノルアドレナリンの前駆物質（ドロキシドパ）MAO阻害剤（セレギリン）抗コリン剤（トリヘキシフェニジル ビペリデン）等

- 精神症状の治療は対処的薬物療法

- 薬剤性パーキンソニズムには注意
- 最近では抑肝散なども用いる

- 脳外科的治療

- 脳深部刺激療法など

多発性硬化症

- 多彩な神経症状が時間的・空間的に増悪・寛解を繰り返す疾患
- 障害部位：大脳・小脳・脳幹・脊髄など多彩
- 炎症性機序による脱髄性変化が生じ、その発生部位により種々の臨床症状は出現
- 日本の有病率は人口10万人あたり8-9人
- 女性にやや多く20-40歳代（30歳前後がピーク）に最も多く見られる

多発性硬化症

- 主に筋力低下や脱力感、歩行障害、知覚障害、視覚障害で初発することが多い
 - 経過中錐体外路障害や失調症状・企図振戦・眼球振盪・眼球運動麻痺・講語障害・膀胱直腸障害・けいれん発作が見られることも
- 全経過の約20%で精神症状が出現
- 精神症状も多彩
 - 抑うつ・不安・焦燥・多幸感・易怒性・易刺激性・精神病症状・情動不安定性・人格変化・認知機能障害・睡眠障害など

多発性硬化症に伴う精神症状 (抑うつ)

- うつ病の出現率は特に高く50%以上に合併する
- 遺伝的要因・免疫学的要因・生活ストレスなど社会的要因の関与が挙げられるが、MS自体で生じる大脳灰白質の脱髄が鬱症状を引き起こしているという意見もある
- 治療に用いられるIFNやステロイドなどの薬剤も鬱を悪化させ、MSによる鬱を複雑化・難治化させる

多発性硬化症に伴う精神症状 (抑うつ)

- MSの重傷度や罹患期間とうつ病の発症率の間には相関はない
- うつ病の出現とMSの増悪が関連しているかは不明
- MSに合併するうつ病では自殺が生じやすく適切な治療介入が不可欠
- 抗うつ剤の中ではパロキセチンが有効 (Koch MW 2011)、CBTも有効 (Hind D2014)

多発性硬化症に伴う精神症状 (精神病症状)

- うつ病と比べると出現率は低い
- 統合失調症で認める症状（幻聴・幻視・被害妄想・関係妄想・誇大妄想・思考障害・させられ体験・注察感・思考伝播）が見られる
- 治療薬としてはSDA（リスペリドン、オランザピン、クエチアピン、クロザピン、アリピプラゾール）などが報告されているが確立されていない
- 認知機能障害として情報処理能力の低下・学習記憶障害がそれぞれ5割以上で生じる（コリンエステラーゼ阻害薬や認知リハビリが有効）

進行性核上麻痺

- 中脳・橋・延髄に高度の萎縮
- 中年以降に発症 男性に多い
- 平均罹患期間は5－6年で進行性
- 臨床症状
 - 核上性眼球運動障害（随意的な上方視と下方視の障害が主）
 - 仮性球麻痺（嚥下障害・構音障害）
 - 体幹と頸部のジストニア
 - 認知症や人格変化

HUNTINGTON病

- 常染色体優性遺伝（Huntington遺伝子）
- 頻度：日本では100万人に1人（欧米だと60–80人）
- 好発年齢：30～40代
- 病理：線条体（特に尾状核）に著名な萎縮
- 症状：素早い不随意運動（舞踏病）→認知症・人格変化
- 治療：不随意運動の対処療法としてハロペリドールやクロナゼパム
- 検査：CT: butterfly appearance
(尾状核の萎縮により側脳室前角が拡大)

脳炎

- 急性脳炎

(単純ヘルペス脳炎・日本脳炎・インフルエンザ等)

- 慢性脳炎 (HIV脳炎等)

- 自己免疫性脳炎

- 抗NMDA受容体脳炎

- 若年女性に発症

- 半数以上が卵巣奇形腫を併発

- 発生機序は不明

- 特異的なMRIやSPECTの所見はない

- 死亡例もあるが比較的予後良好な例が多い

- 感冒様症状→抑うつ・無気力→幻覚妄想状態・混迷状態
(上肢のけいれん・口部など顔面の不随意運動・

- 発汗・頻脈・意識障害・呼吸管理など)

目次

- 医学的疾患による精神障害
 - 症状性精神障害
 - 中毒性精神障害
 - 器質性精神障害
- コンサルテーション・リエゾン精神医学とは？

コンサルテーションとは

相談する側（身体科）が抱えている問題への対応・方策に関して、専門性の異なる相談を受ける側（精神科）がその専門性に沿った情報提供を与えること

異なった専門性・役割を持つものが、それぞれの専門性に基づき状況を検討し、今後の方針に関して話し合い、意思決定をすることが重要

コンサルテーションは患者にとって有益であるだけでなくコンサルティである担当医や病棟スタッフにも有益でなければならない

- 担当医－患者関係や病棟スタッフ－患者関係に配慮する
- 提案は担当医や病棟スタッフが理解でき実際にできることとする

コンサルテーション・リエゾン 精神医学とは？

- コンサルテーション：主診療科の依頼に応じて対応
- リエゾン：問題が生じる前から診療科と精神科が連携
- コンサルテーション・リエゾン精神医学：
 - 診療科の要請に応じて提供される精神医学的サービス全て
 - 身体疾患やその治療の結果生じる精神症状のマネジメント
 - 身体疾患を合併した精神疾患患者のマネジメント
 - がん終末期患者の精神的ケア

コンサルテーションリエゾン 精神医学の対象とする疾患①

疾患名	概要
せん妄	人口の高齢化を受け依頼の頻度が最も高い
薬剤性精神障害	自己免疫疾患などで用いられるステロイドによる躁状態・うつ状態・せん妄、肝炎の治療で用いられるインターフェロンによるうつ状態、抗パーキンソン病薬による幻覚妄想状態やせん妄、癌性疼痛に用いられるオピオイドによるせん妄等
器質性精神障害	内分泌疾患などの結果や脳梗塞や脳髄膜炎など脳そのものが障害を受けて発現する精神疾患
うつ病	がんや神経難病など重篤な進行性の疾患に罹患することによるうつ病を合併することも稀ではない

コンサルテーションリエゾン 精神医学の対象とする疾患②

疾患名	概要
適応障害	うつ病の前駆状態のような抑うつを主体としたもの 疾患の告知に続発する不安を主体としたもの 身体疾患への罹患がストレスとなり情緒的反応を伴うもの 一過性のストレス反応様に自然経過で回復してゆくもの
精神疾患を有する患者の身体合併症のマネジメント	医療チームの一員として精神疾患のマネジメントを行う 例) 周術期の薬物治療、臓器障害時の処方変更、周産期の精神症状のマネジメント など
その他	家族が行わなければならない治療に関する意思決定のサポート、入院によるストレスにより対人関係の問題等が顕在化し軽度の発達障害の存在が疑われる など

死にゆく患者の心理

- キューブラー・ロスの5段階モデル

- 否認
- 怒り「なぜ私が」
- 取引「辛い治療に耐える代わりに病気を治してほしい」等
- 抑うつ
- 受容

- バックマンの3段階モデル

- 初期段階（脅威との直面）：患者特有のストレスに対する急性反応（ex. 怒り、恐怖、ショック、希望、絶望など）
- 中期段階（病気を抱えた状態）：脅威と共存（抑うつが並存することが多い）
- 最終段階（受容）

45歳女性、乳がんの再発で半年外来に通っている。再発であることを告げられた後から不安、不眠、食欲不振及び気分の落ち込みが見られるようになった。最近になって「眠れなくてつらい、もう何もしたくない。生きていても仕方がない」というようになり、表情も乏しくなってきた。

担当医の対応として最も適切なものはどれか？

- A. 経過観察を続ける→×
- B. 頑張るよう励ます→×
- C. 睡眠薬の使用を勧める→×：
抑うつ状態から生じた不眠であるため睡眠薬のみでは不十分
- D. ホスピスへの入院を勧める→×
- E. 精神科医にコンサルテーションする→○

CLチーム・緩和ケアチーム

	CLチーム	緩和ケアチーム
対象	非がん患者、 一部のがん患者 精神症状中心	がん患者とその家族 心不全の患者とその家族 身体症状、精神症状、 終末期ケア、在宅移行、家族ケア
スタッフ	精神科医3名 緩和ケア医（呼吸器内科）2名・（消化器内科）1名	
他職種 スタッフ	専門看護師2名 作業療法士 1 名	専門看護師2名 臨床心理士1名、 薬剤師2名 理学療法士 1 名

まとめ

以下について解説した

- 医学的疾患による精神障害
 - 症状性精神障害
 - 中毒性精神障害
 - 器質性精神障害
- コンサルテーション・リエゾン精神医学とは？